内科含诊断 肝硬化 ★★★（0~6题）

腹水（失代偿期最突出）

- 漏出液：SAAG ≥ 11（2023）
- 门脉高压致静水压和通透性↑（决定因素，2023）、肝淋巴生成增多外溢
  血浆胶渗压↓、肝对醛固酮和抗利尿激素灭活减弱致继发↑
  有效循环血量↓致 RAAS 激活、GFR ↓
- 腹部膨隆、蛙腹、水坑征 / 搔弹音（≥ 120）、移动性浊音（≥ 1000）、液波震颤（≥ 3000~4000）
- 一般治疗
  - 螺内酯（首选，2009）+ 呋塞米 100:40，伴低钠血症可用托伐普坦
    利尿速度不宜过快以免诱发肝性脑病、肝肾综合征
    利尿效果不满意时输白蛋白
  - TIPS（介入）：有效降低门脉压 + 增加肾血流
- 顽固性腹水 —— TIPS；否则排腹水：放 1L 输白蛋白 8g 或腹水浓缩回输（炎性和癌性腹水禁止回输）

并发症

- 消化道出血
  - 食管胃底静脉曲张出血（最常见，2013、2018）
    - 突发呕血（多为鲜血、量大）、黑便、脾脏缩小、侧支循环减轻
      肠鸣音↑、肠源性氮质血症（易诱发肝性脑病）
    - 治疗：收缩压＜ 90 补充血容量；EVL+ 生长抑素 / 奥曲肽、PPI、三代头孢、TIPS、三腔二囊管
    - 一级预防（2022）：对因、普萘洛尔或卡维地洛、EVL（中度食管静脉曲张）
    - 二级预防：TIPS、EVL、注射栓塞剂、普萘洛尔或卡维地洛“二乙医院被塞小费”
  - 门脉高压性胃肠病（呕咖啡样血液）、消化性溃疡等
- 肝性脑病（最严重）

	门静脉血栓形成或海绵样变（2017）	自发性细菌性腹膜炎（2023）
腹痛	有	有
腹水	可迅速增加、血性、漏出液	可迅速增加、渗出液（SAAG ＜ 11、细胞＞ 500 且以多个核中性粒细胞为主，2023）
发热	多无发热（可有血栓吸收热）	低热、腹膜刺激征（2023）
脾脏	短期迅速增大	短期多无明显变化
治疗	早期肝素、尿激酶，晚期 TIPS	头孢哌酮 / 喹诺酮类主要针对 G- 杆菌并兼顾 G+ 球菌（至少 2 周）

- 肝肾综合征（功能性，2011）
  - 少尿无尿、氮质血症、低尿钠、稀释性低血钠（2010、2014）
  - 肝硬化合并腹水、血 Cr ＞ 226/133、停利尿剂＞ 2 天并用白蛋白扩容 Cr 仍＞ 133
    无休克、未用肾毒性或扩血管药、无肾实质病变如尿蛋白＞ 500
  - 肝移植（最有效）、TIPS、补白蛋白 + 抗利尿激素
- 肝肺综合征 —— 肺血管扩张、PaO_2 ＜ 70、呼吸困难、发绀、杵状指
- 原发性肝细胞癌 —— 肝脏肿大或触及不规则质硬结节、肝区疼痛、血性腹水、AFP ↑